PROTOCOLO CLÍNICO MASCULINO 35+

Performance Hormonal, Testosterona & Check-up de Precisão

O guia médico definitivo sobre vitalidade, investigação correta da testosterona, função erétil, saúde metabólica e longevidade masculina baseada em evidências.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NESTE GUIA CLÍNICO:

- Os 5 eixos clínicos que todo homem acima dos 35 anos deve monitorar além do exame básico de sangue;
- Como diferenciar queda real de testosterona (DAEM) de estresse, privação de sono e resistência insulínica;
- Por que implantes hormonais não regulamentados e atalhos comprometem o coração e a fertilidade;
- A relação direta entre saúde vascular/endotelial, potência sexual e prevenção cardiovascular.

Dr. Felipe de Bulhões

MÉDICO · Urologista & Cirurgião Geral · CRM-SP 202.291 | RQE 146538 / 114019
Residência em Urologia pelo Instituto D'Or de Ensino e Pesquisa (IDOR-SP) · Titular do CBC (TCBC)

TCBC · IDOR-SP · SBU · AUA · EAU
SÃO PAULO & CAMPINAS

Olá! Sou o Dr. Felipe de Bulhões, médico Urologista (IDOR) e Cirurgião Geral (TCBC).

Na prática clínica em São Paulo e Campinas, atendo diariamente homens produtivos que relatam queda de energia, redução da libido, perda de massa muscular ou oscilações na qualidade da ereção — muitas vezes tratados apenas como "estresse da rotina" ou expostos a protocolos hormonais sem critério médico. Este guia foi estruturado para mostrar como funciona uma investigação andrológica e metabólica de alta precisão.

1. Os 5 Eixos do Check-up Uro-Hormonal de Precisão

Um check-up masculino moderno não se resume a pedir "colesterol e PSA". Na consulta integral, avaliamos o organismo masculino como um sistema integrado onde metabolismo, endotélio vascular, sono e eixo hormonal determinam sua performance física, mental e sexual:

EIXO CLÍNICO	O QUE INVESTIGAMOS	IMPACTO DIRETO NO PACIENTE
1. Eixo Androgênico Completo	Testosterona Total e Livre Calculada (duas coletas matinais em jejum), SHBG, LH, FSH, Prolactina e Estradiol.	Regula libido, vigor físico, síntese muscular, densidade óssea, humor e foco cognitivo.
2. Eixo Cardiometabólico	Glicemia, Hemoglobina Glicada, Insulina basal (HOMA-IR), perfil lipídico avançado, ácido úrico e inflamação.	A gordura visceral converte testosterona em estrogênio (aromatização) e inflama a parede arterial.
3. Função Endotelial & Sexual	Qualidade das ereções matinais e espontâneas, rigidez axial e avaliação vascular peniana quando indicada.	As artérias cavernosas (1–2 mm) dão sinais de alerta endotelial 3 a 5 anos antes das coronárias.
4. Saúde Prostática & Urinária	PSA individualizado, cinética do PSA, força do jato urinário, esvaziamento vesical e exame físico dirigido.	Garante segurança obrigatória antes e durante qualquer otimização hormonal e previne obstrução urinária.
5. Segurança Hematológica	Hemograma completo (Hematócrito/Hemoglobina), função hepática, renal, tireoidiana (TSH/T4L) e vitaminas.	Previne policitemia (espessamento sanguíneo) e identifica causas reversíveis de fadiga crônica.

2. Testosterona: Quando Repor com Segurança Máxima

Segundo as diretrizes da **European Association of Urology (EAU)** e da **American Urological Association (AUA)**, o diagnóstico de Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (DAEM / Hipogonadismo) exige a combinação de **sintomas clínicos consistentes** somados a **níveis bioquimicamente reduzidos** confirmados em duas coletas matinais (entre 7h e 10h).

ALERTA MÉDICO: O PERIGO DOS "CHIPS" E FÓRMULAS SEM DIAGNÓSTICO

O uso de implantes hormonais manipulados ("chips da beleza/performance") ou doses suprafisiológicas sem indicação médica bloqueia o eixo hipófise-testículo, pode causar atrofia testicular, infertilidade severa (azoospermia), elevação perigosa do hematócrito (risco de trombose/AVC) e instabilidade emocional. Quando bem indicada e monitorada por urologista, a Terapia de Reposição de Testosterona (TRT) com medicações aprovadas é altamente segura e restauradora.

3. Ereção, Libido e Performance: Tratamento da Causa Raiz

Enquanto a **libido (desejo)** tem forte comando hormonal e neuroquímico central, a **ereção** é um fenômeno essencialmente hemodinâmico e endotelial. Tratar uma oscilação erétil apenas com comprimidos sob demanda sem investigar a causa equivale a silenciar um alarme sem apagar o incêndio.

Abordagem Diagnóstica Individualizada

- Diferenciação precisa entre componente psicogênico/ansiedade de performance e componente orgânico (vascular, hormonal ou medicamentoso);
- Avaliação do sono (a Apneia Obstrutiva do Sono reduz drasticamente os picos noturnos de testosterona e oxigenação cavernosa);
- Revisão de medicamentos de uso contínuo (anti-hipertensivos ou antidepressivos que afetam a resposta sexual).

Arsenal Terapêutico Escalonado

- **1ª Linha:** Reabilitação endotelial, ajuste metabólico/hormonal e farmacoterapia oral personalizada (uso diário de baixa dose ou sob demanda);
- **2ª Linha:** Terapias regenerativas locais e farmacoterapia intracavernosa de precisão para casos refratários;
- **3ª Linha:** Implante de prótese peniana (maleável ou inflável de 3 volumes) com altíssimo índice de satisfação.

4. Pilares de Estilo de Vida que Multiplicam a Resposta Clínica

Nenhuma intervenção farmacológica atinge seu potencial máximo se o ambiente metabólico estiver inflamado. Três ajustes fisiológicos potencializam diretamente a produção endógena de testosterona e a função erétil: **(1) Treinamento de força associado a cardio em Zona 2** (reduz resistência insulínica e aumenta receptores androgênicos); **(2) Sono profundo de 7 a 8 horas** (mais de 70% da liberação diária de testosterona ocorre durante o sono REM); e **(3) Redução da circunferência abdominal** (menor conversão periférica de testosterona em estradiol).

Autoavaliação Andrológica: Você Apresenta Algum Destes Sinais? AUTOAVALIAÇÃO CLÍNICA

- ☐ Queda perceptível da energia física, disposição ou produtividade no fim da tarde;
- ☐ Oscilação na rigidez da ereção ou necessidade de maior estímulo para mantê-la;
- ☐ Sono não reparador, irritabilidade frequente ou queda de concentração/memória;
- ☐ Redução do desejo sexual (libido) ou diminuição das ereções espontâneas matinais;
- ☐ Dificuldade para ganhar massa muscular ou acúmulo recente de gordura abdominal;
- ☐ Mais de 12 meses sem realizar check-up urológico, hormonal e prostático completo.

Interpretação Clínica: Se você assinalou 2 ou mais itens acima, uma investigação urológica e hormonal individualizada é fortemente recomendada para identificar causas tratáveis com segurança.

5. Como Funciona Nossa Consulta de Investigação Integral

Em nossos consultórios em São Paulo (Av. Paulista e Pinheiros) e Campinas (Cambuí e Rede D'Or São Luiz), a primeira consulta é desenhada para ouvir sua história sem pressa e construir um mapa completo da sua saúde:

ETAPA DA AVALIAÇÃO	O QUE É REALIZADO
1. Anamnese Dirigida & Escuta	Avaliação detalhada de sintomas de vitalidade, rotina de sono, estresse, função sexual, histórico familiar e objetivos de performance e fertilidade futura.
2. Exame Físico & Antropometria	Avaliação clínica urológica/andrológica completa, composição corporal, distribuição de peso e exame prostático quando indicado pela faixa etária.
3. Painel Laboratorial & Funcional	Solicitação criteriosa do perfil hormonal matinal, metabólico, inflamatório e exames de imagem/urofluxometria conforme necessidade clínica.
4. Plano Terapêutico Sob Medida	Definição compartilhada da estratégia ideal — com monitoramento periódico de eficácia e segurança prostática, hematológica e cardiovascular.

Locais Oficiais de Atendimento & Teleconsulta

São Paulo — Clinovi Paulista
Av. Paulista, 1048, 18º andar — Bela Vista, São Paulo - SP

São Paulo — Clinovi Pinheiros
Av. Rebouças, 2636 — Pinheiros, São Paulo - SP

Campinas — Campinas Day Hospital
Av. Benjamin Constant, 1991 — Cambuí, Campinas - SP

Campinas — Hospital São Luiz Campinas (Rede D'Or)
Av. Andrade Neves, 863 — Centro, Campinas - SP · + Teleconsulta

Próximo Passo: Avaliação Médica Individualizada

Deseja discutir seu caso com discrição absoluta, precisão diagnóstica e plano terapêutico sob medida? Nossa equipe de atendimento está pronta para orientar seu agendamento presencial ou por teleconsulta.

Falar no WhatsApp: (11) 98112-4455 | **Agendar pelo Site Oficial**

Ciência • Saúde • Discrição • Resultados • Masculinidade • Longevidade

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS & CONFORMIDADE ÉTICA (RESOLUÇÃO CFM Nº 2.336/2023)

1. Salonia A, Bettocchi C, Boeri L, et al. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health. European Association of Urology, 2025/2026.
2. Mulhall JP, Trost LW, Brannigan RE, et al. Evaluation and Management of Testosterone Deficiency: AUA Guideline. J Urol. 2018;200(2):423-432.
3. Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Diretrizes de Disfunção Erétil e Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino.
4. Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução CFM nº 2.333/2023 e Resolução CFM nº 2.336/2023. Este material tem caráter estritamente educativo e não substitui consulta médica presencial ou por telemedicina.